

Variaciones de la forma y tamaño de la cabeza

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Neurología para Pediatras J. Campistol 2012

Macrocefalia

Crecimiento del perímetro craneal frontooccipital máximo, por encima del P98 o de 2 DS por encima de la media para la edad cronológica.

Se debe evaluar el crecimiento, no se considera patológico un niño que nace con el perímetro craneal aumentado y que se mantiene a lo largo del tiempo en el mismo percentil y libre de síntomas neurológicos.

Etiologías

- 1- Aumento normal del volumen del cerebro (megalencefalia)
- 2- Macrocefalia por presencia de colecciones líquidas extracerebrales:
 - a- Hidrocefalia benigna externa
 - b- Hematoma subdural crónico
 - c- Quiste aracnoideo
- 3- Aumento anormal del contenido de LCR: Hidrocefalia
- 4- Por presencia intracerebral de colecciones:
 - a- Líquidas: abscesos
 - b- Masas sólidas: tumores
 - c- Malformaciones del sistema nervioso
- 5- Aumento de calota craneal (en talasemia mayor) o en displasia ósea (acondroplasia, osteogénesis imperfecta, etc.)
- 6- Por anomalías venosas congénitas

Megalencefalia

1- Idiopática o anatómica

Hay niños que presentan ya desde el nacimiento una macrocefalia macrocefalia que persiste con el paso del tiempo. Su perímetro cefálico crece exageradamente por encima de +2 DE, especialmente durante los primeros 10-18 meses de vida. No manifiestan clínica de hipertensión intracraneana como vómitos, cefaleas, irritabilidad o diástasis de suturas. La ecografía craneal transfontanelar o la TC craneal (cuando la ecografía no sea posible de realizar o resulte difícil de interpretar) no evidencian alteraciones en el parénquima cerebral ni en las estructuras adyacentes o simplemente muestran unos ventrículos sólo ligeramente dilatados o la presencia de un ligero incremento del líquido en los espacios de la convexidad que no justifican el mayor tamaño.

La medida del PC de los progenitores y la ausencia de signos de compromiso neurológico facilitan la orientación clínica. En realidad deben ser considerados como **variaciones de la normalidad**. Su identificación evita exploraciones innecesarias y resuelve la ansiedad familiar relacionada con el futuro del niño.

2- Megalencefalias sintomáticas o metabólicas

En otras ocasiones los niños presentan signos de disfunción neurológica en forma de retardo global del desarrollo o retardo mental, hipotonía, movimientos anormales, crisis epilépticas u otras anomalías sistémicas, y se deben estudiar con mayor profundidad. Corresponden a las denominadas megalencefalias anatómicas sintomáticas, heredadas con carácter autosómico dominante (AD) o autosómico recesivo (AR), pueden obedecer a diferentes causas y encuadrarse en un síndrome concreto, por ejemplo neurofibromatosis tipo I, esclerodermia tuberosa, etc.

Macrocefalia por presencia de colecciones líquidas extracerebrales

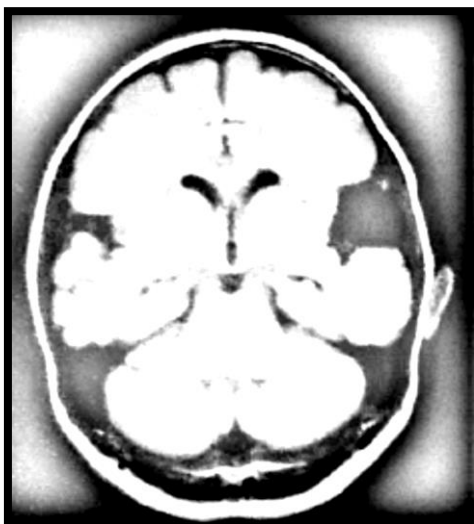
1- Hidrocefalia externa benigna

Es un cuadro relativamente frecuente que puede afectar al 10% de los lactantes, más común en sexo masculino, y presentarse en varios miembros de una misma familia. Al nacer el PC es normal y suele ascender su crecimiento en los primeros meses de vida hasta alcanzar el percentil 98 hacia los 8-12 meses de vida. Posteriormente se mantiene PC en el mismo percentil y a partir de los 14-24 meses el cuadro tiende a compensarse, especialmente

coincidiendo con cierre de las fontanelas, que por otra parte es más tardío en este grupo poblacional. Se va reabsorbiendo el líquido de la Convexidad, la neuroimagen tiende a normalizarse y puede persistir una cierra macrocefalia.

El examen físico y de desarrollo están dentro de la normalidad, quizás con ligero retardo motor (control cefálico algo tardío por la misma macrocefalia), la fontanela suele ser normotensa, ocasionalmente llena y pulsátil, pero sin signos de hipertensión endocraneal. Algunos niños pueden presentar grados variables de déficit motor o cognitivo, pero es dudoso que estos signos se deban a la hidrocefalia externa.

La ccografía craneal transfontanelar, que es la técnica de elección, o bien, si esta no es posible, mediante TC o RM craneal, evidencia un aumento de los espacios subaracnoideos de la convexidad y de claro predominio anterior, con escasa dilatación ventricular, contrariamente a la hidrocefalia, donde los espacios subaracnoideos están comprimidos y los ventrículos muy dilatados.



La fisiopatología de este proceso no está aclarada.

Con relativa frecuencia la hidrocefalia externa benigna es causa de errores diagnósticos, como por ejemplo considerar la dilatación de los espacios subaracnoideos como un signo de atrofia cerebral; la normalidad del examen clínico, la macrocefalia, la excelente evolución, la localización anterior del líquido acumulado y la desaparición de la hidrocefalia externa con el tiempo descartan el diagnóstico de atrofia, que por otro lado es un diagnóstico anatomopatológico y no radiológico.

2- Hematoma subdural crónico

Se trata la colección de líquido serosanguinolento localizada entre la aracnoides y la duramadre, debido a un sangrado venoso por rotura de las venas puentes corticales.

La presencia del sangrado puede ser aguda (tras un traumatismo de cráneo con manifestaciones clínicas precoces), subaguda o crónica.

La TAC craneal y, especialmente, la RM confirman el diagnóstico. El hematoma subdural crónico es más *propio* de personas de edad avanzada, alcohólicos o en tratamiento con anticoagulantes. Son infrecuentes en pediatría y la mayoría se manifiestan en lactantes o niños pequeños después de traumatismos.

3- Quistes aracnoideos

Los quistes aracnoideos son colecciones líquidas intracraneanas extracerebrales debidas a la evaginación o duplicación del espacio subaracnoideo y localizados en diferentes áreas del cerebro.

Su sintomatología es variable y los pacientes pueden incluso permanecer asintomáticos de por vida.

La clínica depende de la localización y de la edad del paciente. En muchas ocasiones, a pesar de su gran tamaño, pueden ser muy bien tolerados o evidenciarse casualmente en una exploración neurorradiológica por otro motivo o simplemente por la macrocefalia.

Hidrocefalia (AEP Módulo 26)

Se define como un incremento del volumen total de líquido cefalorraquídeo en el interior de la cavidad craneal, lo que conlleva un aumento del tamaño de los espacios que lo contienen (ventrículos, espacios subaracnoideos y cisternas de la base).

El LCR tiene tres funciones vitales: Envuelve por completo médula y cerebro lo que supone un mecanismo antichoque que les protege de traumatismos. Sirve de vehículo para transportar nutrientes al cerebro y eliminar desechos. Fluye entre el cráneo y canal raquídeo para compensar los cambios de volumen de sangre intracraneal, con el fin de evitar incrementos excesivos de presión intracraneal.

Clasificación

1- Hidrocefalia activa

Es aquella que se produce como consecuencia de un desequilibrio en la producción, circulación o reabsorción de LCR, bien por un aumento de la producción a nivel de los plexos coroides, por obstrucción a la circulación a través de sus vías de drenaje o por disminución de la reabsorción en los corpúsculos aracnoideos de Pacchioni.

2- Hidrocefalia pasiva” o hidrocéfalo “ex vacuo”

Es una dilatación de las cavidades de LCR por disminución de la masa cerebral.

Manifestaciones clínicas

Dependen de la edad de inicio de la hidrocefalia, dado que la compliance craneal mucho más reducida en el niño mayor de dos años con suturas craneales cerradas, no puede compensar con el crecimiento cefálico el aumento de LCR, dando lugar a una sintomatología más intensa y rápidamente progresiva de hipertensión endocraneal

Niños menores de 2 años:

- Macrocefalia.
- Desproporción craneofacial.
- Fontanela abombada o tensa.
- Diástasis de suturas / venas pericraneales dilatadas.
- Signos oculares (ojos en sol poniente/estrabismo).
- Irritabilidad vómitos.
- Retraso psicomotor.

Niños mayores de 2 años:

- Cefalea.
- Vómitos.
- Letargia.
- Estrabismo (endotropia por afectación VI par)
- Edema de papila en el fondo de ojo.

Exámenes complementarios

El diagnóstico de la hidrocefalia se basa sobre todo en la neuroimagen. La ecografía transfontanelar puede ser una técnica inocua de diagnóstico, aunque tiene sus limitaciones cuando se trata de valorar estructuras laterales separadas de la línea media. Como técnica inicial se prefiere la TAC de cerebro

Tratamiento

El tratamiento de la hidrocefalia es básicamente el de la causa que la provoca, procediendo siempre que sea posible a la extirpación de masas ocupantes de espacio (tumores, quistes, malformaciones vasculares).

No obstante una gran mayoría de hidrocefalias secundarias a procesos hemorrágicos, inflamatorios o malformativos, precisan de tratamientos derivativos del LCR con sistemas de derivación extracraneal.

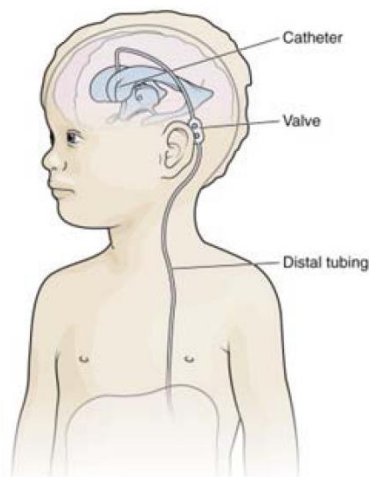
El tratamiento médico puede valorarse en casos de dilatación ventricular moderada y lenta progresión de la hidrocefalia, empleando Acetazolamida a la dosis de 25-100 mg/Kg de peso/día o Furosemida a la dosis de 1 mg/Kg de peso/día, en un intento de disminuir la producción de LCR.

Clasificación etiológica

HIPERSECRECIÓN de LCR	Papiloma de plexo coroides Coroidoplexitis.
OBSTRUCCIÓN de la circulación de LCR	
Bloqueo intraventricular: Agujero de Monro III ventrículo Acueducto de Silvio IV ventrículo	Tumores (Astrocitoma células gigantes) Craneofaringioma. Quiste coloide. Tumores, malformaciones, procesos inflamatorios (hemorragia, infección). Tumores y malformaciones (Dandy-Walker, Arnold Chiari).
Bloqueo extraventricular: Bloqueo basilar Bloqueo de la convexidad	Procesos inflamatorios (infección o hemorragia). Procesos inflamatorios.
REABSORCIÓN deficiente de LCR	
Hipertensión venosa Anomalías de los corpúsculos aracnoideos de Pacchioni	Compresión de senos venosos. Obstáculos venosos extracraneales (trombosis venosa). Ausencia congénita. Atasco por LCR hiperproteico.
MECANISMOS DESCONOCIDOS	
Tumores medulares. Síndrome de Guillain – Barré.	

Complicaciones de los sistemas de derivación ventrículo-peritoneal

- Infecciones (meningitis, ventriculitis)
- Obstrucción mecánica del sistema.
- Peritonitis.
- Ascitis de LCR / quistes abdominales.
- Hernias inguinales.
- Migración de la derivación al interior de la cavidad abdominal.
- SÍNDROMES DE HIPERDRENAJE de LCR.
 - Obstrucción del extremo ventricular de la derivación.
 - Colapso ventricular sintomático (slit ventricle syndrome).
 - Hematoma subdural.
 - Cuarto ventrículo aislado



Clínica y factores de riesgo para sospechar fallo de la DVP

Anamnesis

Revisar siempre el historial (enfermedad de base y complicaciones asociadas a su enfermedad, tratamientos, fecha última intervención quirúrgica, número de recambios valvulares) y estudios radiológicos previos si fuera posible (fecha última neuroimagen).
 Proceso actual: tiempo de evolución y síntomas.

Síntomas de HTIC según edad (Tabla 1). La presencia de fiebre puede indicar una infección del sistema (más probable si hay intervención reciente en los últimos 2 meses, sucesivas

revisiones de la DVP, colocación < 1 año, afectación del estado general sin foco, mielomeningocele).

El germen más frecuente es el *Estafilococo epidermidis*. Los síntomas más específicos de disfunción valvular son la somnolencia, letargia, irritabilidad o tumefacción a nivel de la derivación, mientras que otros como la cefalea y los vómitos son mucho más inespecíficos.

Exploración física

1- Exploración neurológica completa (Glasgow, pupilas y oculomotricidad, asimetrías motoras, inestabilidad, etc.), que incluya fondo de ojo (no necesario si niño no colabora y síntomas de pocas horas de evolución).

La presencia de papiledema (no evidenciado en controles previos) indicará la realización de neuroimagen urgente.

2- Palpación del trayecto de la DVP, sobre todo a nivel cervical, y la comprobación de la elasticidad del reservorio nos pueden orientar hacia un problema mecánico-obstrutivo (más frecuente en el extremo proximal o ventricular; por presencia de parénquima cerebral, plexo coroideo, taponamiento proteico o células tumorales). La desconexión tiene más riesgo en la zona de mayor movilidad, como es la zona lateral del cuello.

En ocasiones pueden surgir complicaciones abdominales por el catéter distal (obstrucciones intestinales, perforación de vísceras) o si queda corto la longitud al crecer se debe recambiar. Debe evitarse, por lo general, la manipulación del sistema valvular (bombeos o punciones del reservorio).

3- Palpación del reservorio en los sistemas que tengan:

Obstrucción proximal (deprimes y tarda mucho en rellenar o persiste deprimido).

Obstrucción distal (no se deprime o difícil de deprimir pero se rellena con facilidad)

Complicaciones a corto/largo plazo

Aproximadamente el 40% de las derivaciones fallan <1 año después de la colocación. A más recambios valvulares mayor probabilidad de complicaciones.

- Infecciones (meningitis, ventriculitis): 5-10%. La mayoría ocurren <6 meses. Puede darse a distintos niveles del trayecto, con el riesgo de diseminación posterior.
- Obstrucción mecánica del sistema, peritonitis, ascitis de LCR/quistes abdominales, hernias inguinales, migración de la derivación al interior de la cavidad abdominal.

Complicaciones tardías

- Síndromes de hiperdrenaje de LCR: obstrucción del extremo ventricular de la derivación, hematoma subdural, cuarto ventrículo aislado, síndrome de colapso ventricular (SCV) (Slit ventricle syndrome)
Síntomas de HTIC (episodios intermitentes de cefalea, vómitos y grados variables de afectación de la conciencia)
Contactar con Neurocirugía (valorar únicamente la posibilidad de añadir dexametasona 0,5mg/kg/d como alivio previo a la intervención)
- Epilepsia.

Actuación en urgencias

1- En niños con fontanela abierta: **ECO cerebral**.

2- Si hay claros síntomas de **HTIC**: estabilización inicial.

3- TAC craneal urgente: comparar si tiene imágenes previas.

4- Consulta a Neurocirugía:

En caso de urgencia vital por HTIC aguda o ante posibilidad de ventriculitis o meningoencefalitis valorar la punción del reservorio. Si **encefalopatía** aguda/Glasgow <15 valoraremos de entrada traslado e ingreso en UCIP.

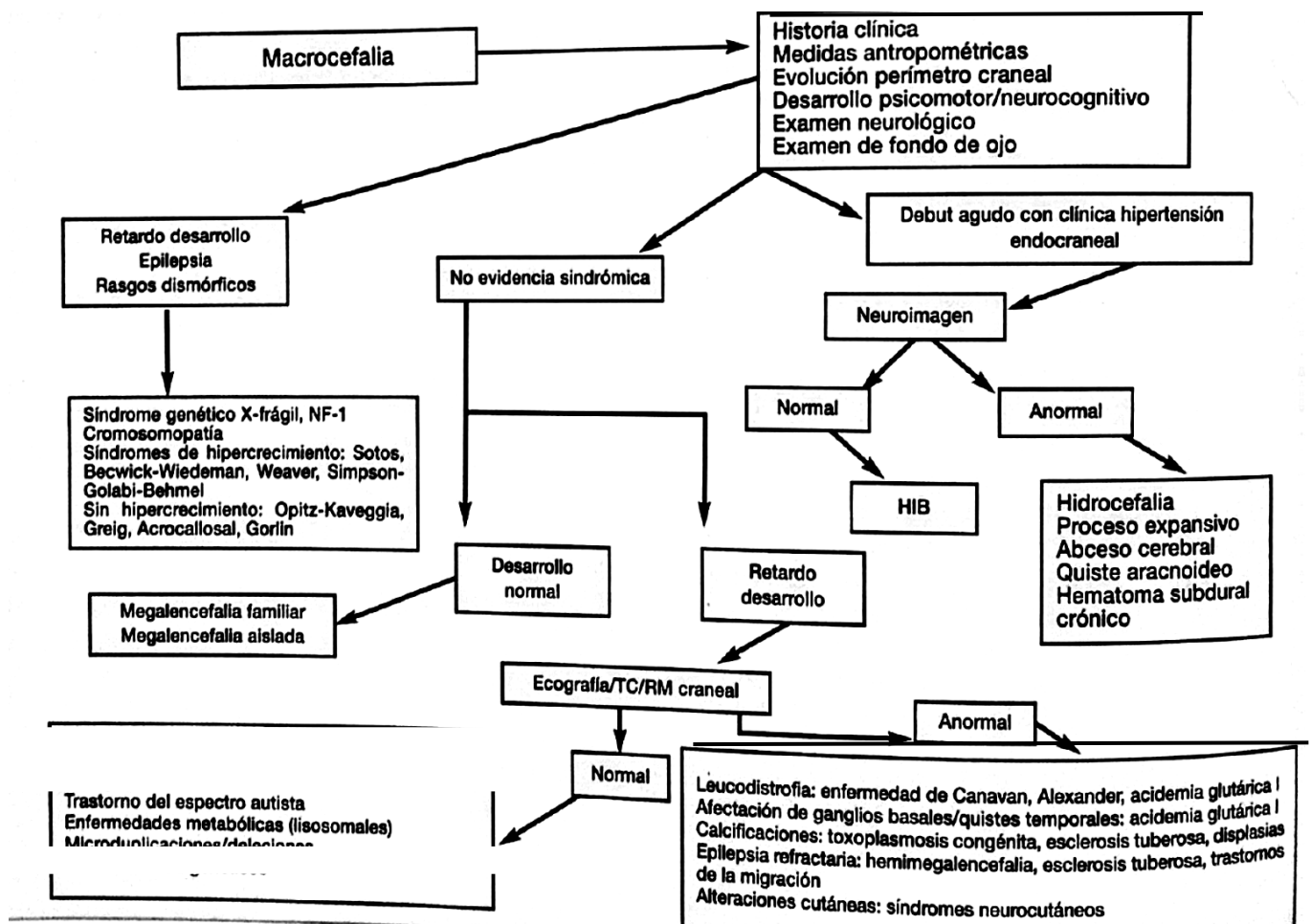
Si el niño no impresiona de gravedad con síntomas inespecíficos y buen estado general: (Glasgow 15 y en todo caso somnolencia y/o irritabilidad con cefalea sin focalidad)

neurológica y vómitos aislados) permanecerá en Unidad de Observación hasta realización de TAC y decisión de traslado por parte de Neurocirugía.

Valorar las siguientes pruebas tras contactar con neurocirugía:

- 1- Trayecto valvular (TV): radiografías craneal (AP/LAT), torácicacervical y abdominal): buscando acodamientos, desconexión. Es recomendable realizarlas aunque se haga TAC cerebral o éste sea normal.
- 2- ECO abdominal/Rx abdomen para descartar la presencia de obstrucción distal por pseudoquistes de LCR peritoneal (clínica de peritonitis sin fiebre).
- 3- Si fiebre añadida valorar la extracción de LCR del reservorio, (tras TAC cerebral) si es posible.

Algoritmo de Macrocefalias



Microcefalia

PC del niño por debajo del percentil 2 o -2DE para la edad cronológica. Consideramos microcefalia extrema cuando el PC se sitúa por debajo de -3DE.

La curva de crecimiento del perímetro craneal es un dato que nos permite orientar hacia una **microcefalia congénita** de la adquirida, donde el PC al nacer está en la media o en percentil 50 y a los 2 o 3 años (o antes) se desacelera hasta < 3 DE o está en el percentil 2. Otra posibilidad es que después de una agresión puntual sobre el sistema nervioso (hipoxia aguda, traumatismo craneal infección del SNC, estado de mal epiléptico) el perímetro craneal deja de crecer y se estaciona.

Patogenia

Mecanismos principales:

- Microcefalia congénita: defecto en el desarrollo cerebral con reducción del número de neuronas durante la neurogenesis o inadecuada migración neuronal.
- Microcefalia secundaria o adquirida: agresión sobre un cerebro previamente normal.
- Craneosinostosis: limitación del crecimiento del cerebro.

Etiología

1. Aisladas o primarias
Autosómica recesiva
Autosómica dominante
Ligada al X (gen PQBP1)
2. Sindrómica
Asociada a anomalías cromosómicas, delección genes contiguos, defectos génicos únicos o varios
Síndromes: Seckel, Smith Lemli Opitz, Williams, Brachman de Lange, Rubinstein Taybi, Bloom, Down
3. Defectos malformativos
Anomalías neuroanatómicas
Defectos tubo neural: anencefalia, hidranencefalia, encefalocele
Malformaciones SNC: holoprosencefalia, liencefalia, esquisencefalia, polimicrogiria, paquigiria
4. Craneosinostosis
5. Enfermedades metabólicas
Diabetes mellitus materna
Embriopatía por PKU materna
PKU no tratada
Acidurias orgánicas (con algunas excepciones: aciduria glutámica tipo I, A. mevalónica)
Citrulinemia
Peroxisomales
Defectos de creatina cerebral

6. Enfermedades neurodegenerativas
Síndrome de Rett
Síndrome de Alpers
Lipofuscinosis cerioidea
Síndrome de Aicardi-Goutières
7. Factores ambientales
Infecciones congénitas (TORCH)
Infección SNC
Infección por VIH
Exposición drogas/tóxicos durante gestación (alcohol, tabaco, drogas, antiepilépticos, radiación, anti-neoplásicos)
Problemas perinatales (hipoxia-isquemia, hipoglucemia, convulsiones, hipotiroidismo)
Traumatismo craneal
Casi ahogamiento
Malos tratos
Estado de mal epiléptico

Microcefalia aislada o primaria

Microcefalia debido a defecto de la proliferación, se presenta desde el nacimiento sin otras manifestaciones clínicas. Puede heredarse con carácter AR, AD o ligada al X, con manifestaciones clínicas diferentes.

Cursa con talla baja y retardo del desarrollo o mental, el niño puede tener un desarrollo motor adecuado hasta inclusive los 2 años.

El cerebro no muestra un proceso destructivo (neuroimágenes normal), pero es pequeño y crece lentamente.

La mc AD es menos severa que la AR, con talla (N) y nivel intelectual normal-bajo/límite, y sin asociar otras anomalías semánticas.

La ligada al X cursa con severo déficit intelectual.

Conducta frente a un niño con microcefalia

1. Historia prenatal y perinatal, datos del PC de los progenitores, antecedentes familiares de microcefalia o de alguna enfermedad neurodegenerativa, la historia clínica de la madre: ingesta de alcohol, serología durante el embarazo, parto, Apgar al nacer.
2. Examen físico completo, un examen neurológico, sensorial y la valoración del desarrollo. El hallazgo de rasgos dismórficos contribuye a sospechar una anomalía cromosómica.
3. Examen oftalmológico con detalle del fondo de ojo para descartar la presencia de atrofia óptica, coriorretinitis u otras anomalías asociadas a la microcefalia.

Ante la sospecha de una **craneosinostosis** como responsable de la microcefalia, realizar una radiografía simple de cráneo en proyección AP y de perfil.

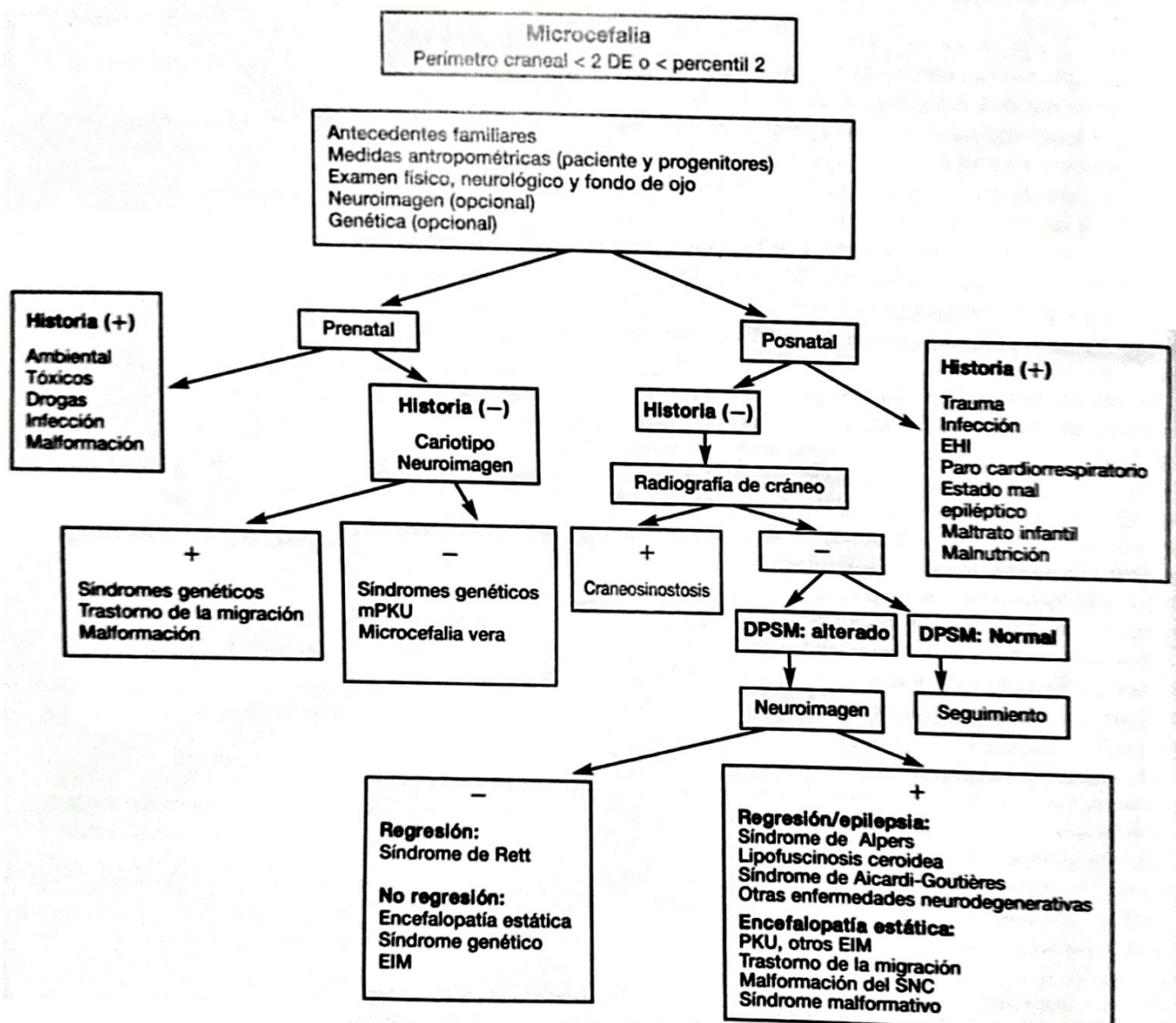
Siempre que la fontanela permanezca abierta será obligatoria una ecografía craneal transfontanelar, que nos permite evidenciar calcificaciones intracraneales, anomalías de línea media y lesiones parenquimatosas de origen prenatal o posnatal.

Ante la negatividad de estas exploraciones iniciales, y si la microcefalia se acompaña de retardo del desarrollo, debemos descartar una infección congénita del grupo TORCHS. Cuando han transcurrido más de 2 años las determinaciones serológicas carecen de valor.

El paso siguiente es el examen mediante TC/RM craneal para descartar la presencia de calcificaciones (no siempre se observan por ecografía y se evidencian mejor por TC craneal) o de malformaciones del sistema nervioso central (que se visualizan mejor por RM craneal).

Si la microcefalia se asocia a dismorfias y problemas cardíacos, especialmente en una primera gestación debemos descartar la embriopatía por PKU materna.

Algoritmo



DPSM: desarrollo psicomotor

Variaciones de la forma de la cabeza

Craneosinostosis

Consiste en el cierre prematuro de una o más suturas craneales.

Plagiocefalia postural posterior

Deformidad craneal del lactante que consiste en el aplanamiento del occipital de un lado, siendo las suturas normales, se presenta en 1/10 recién nacidos vivos y representa un motivo de consulta frecuente en pediatría.

La fontanela posterior suele cerrarse hacia los 2 meses y la anterior hacia los 2 años, aunque es muy variable.

La única sutura que se cierra en el primer año de vida es la metópica, mientras que las demás quedan permeables hasta el final del crecimiento del individuo.

Influencia en la forma final de la cabeza

Factores genéticos

El patrón morfológico tiende a repetirse en las siguientes generaciones, dentro de una normalidad. En las craneosinostosis sindrómicas se han podido identificar mutaciones en genes específicos en la mayoría de las formas autosómicas dominantes.

Hasta ahora poco se sabe de las no sindrómicas.

Factores estáticos

El cierre prematuro de una sutura craneal impide el crecimiento normal del cráneo y provoca que el cerebro en expansión lo deforme, con lo que crece paralelamente a la sutura cerrada. Así, en las craneosinostosis monosuturarias el cráneo adopta una forma característica que facilita el diagnóstico clínico.

Por ejemplo, en la **craneosinostosis** de la sutura sagital o escafocefalia (la más frecuente), el cráneo es “apepinado”, mucho más largo que ancho; en cambio, en la braquicefalia, que es la sinostosis de las dos coronales, el cráneo es justo al contrario, ancho y corto.

Factores dinámicos

El apoyo prolongado sobre una zona de la cabeza del bebé facilita la aparición de la deformidad propia de la **plagiocefalia posicional posterior**.

El occipital se aplanar y el frontal del mismo lado abomba, desplazando el pabellón auricular también hacia delante. Esta situación es relativamente fácil de distinguir de la sinostosis de la sutura lambdoidea, en que el occipital también se aplanar pero es el otro lado del frontal el que intenta abombarse, quedando el pabellón en situación más o menos neutra.

Craneosinostosis

1) Repercusión estética

2) Repercusión funcional

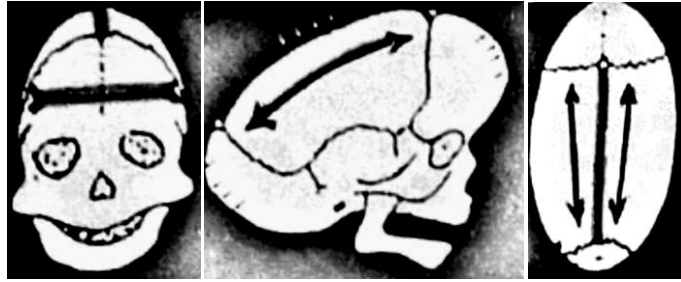
Las deformidades de la cara pueden afectar a las órbitas, presentando diversos grados de estrabismo, ambliopía, etc. También pueden afectar al tercio medio de la cara, presentando dificultad respiratoria o deglutoria. Finalmente, son frecuentes las alteraciones en la dentición y trastornos relacionados con la maloclusión dentaria que pueden requerir múltiples intervenciones.

3) Repercusión neurológica

Las sinostosis complejas no tratadas pueden aumentar la presión intracraneal (PIC), con importantes complicaciones visuales y cognitivas.

Escafocefalia

Es la fusión prematura de la sutura sagital. El cráneo es alargado y estrecho



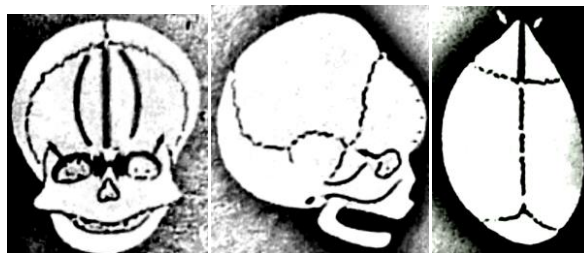
Plagiocefalia anterior

Fusión prematura de una sutura coronal.



Trigonocefalia

Fusión prematura de la sutura metópica, con frente en forma de quilla, triangular. Según el grado, muy variable, puede consistir en una cresta simple sobre la sutura o alterar gravemente.



Plagiocefalia postural posterior

Estos niños presentan con más frecuencia algún tipo de alteración del desarrollo neuropsicológico, aunque pueden tener un desarrollo (N).

Puede estar asociada a **tortícolis congénito**. El niño no puede mover la cabeza libremente y tiene tendencia a tenerla siempre girada hacia un lado; la presión ejercida sobre ese lado va deformando la cabeza. Es importante el diagnóstico precoz de esta condición para evitar el desarrollo de una verdadera plagiocefalia.

Las alteraciones de la forma de la cabeza pueden estar presentes desde el nacimiento. Si es así, hay que volver a ver al niño en el plazo de 1 mes, ya que la evolución puede arrojar mucha luz al diagnóstico.

En la **craneosinostosis** suele estar presente ya en el nacimiento y va empeorando con el tiempo.

Todas las demás causas de deformidad craneal que tienen que ver con el embarazo (gemelos) o con el parto (moldeado en el canal del parto, parto instrumentado, cefalohematoma), tienen que solucionarse o estar en vías de solución al cabo de 1 mes.

La plagiocefalia es postural y por tanto no aparece en el nacimiento, sino que se va instaurando en los siguientes meses de vida.

Técnicas de imagen

- **Las radiografías** simples en las tres proyecciones clásicas: anteroposterior, lateral y Towne (para la fosa posterior) permiten ver la integridad de las suturas, aunque es necesario un cierto entrenamiento.
- **TC 3D:** es la prueba de elección hoy en día. Sirve tanto para confirmar el diagnóstico, ya que permite visualizar perfectamente las suturas, como para ver la integridad o patología de las estructuras intracraneales (hidrocefalia, defectos de línea media, etc.).
- **Ecografía transfontanelar:** puede ser suficiente para comprobar la integridad intracraneal en lactantes con plagiocefalia postural o sinostosis sagital con diagnóstico clínico evidente.

La RM es necesaria básicamente en las sinostosis sindrómicas.

Tratamiento

Craneosinostosis

Cirugía craneofacial. Siempre que exista hidrocefalia se deberá poner remedio a este problema previamente a la remodelación craneal.

Suturectomía

La técnica de intervención depende de la edad, por encima de los 6 meses, la osificación es más difícil, los huesos más consistentes y por tanto la técnica es más compleja y requiere la remodelación de la bóveda.

Plagiocefalia postural posterior

En el lactante pequeño se trata de cambiar frecuentemente de lado la cabeza cuando está apoyada y tenerlo en el cochecito lo menos posible utilizando las mochilas de transporte vertical. Cuando se va haciendo mayor hay que ir introduciendo el **tummy time** o tiempo de juego sobre la barriga para aumentar el control cefálico y que apoye la cabeza lo menos posible. Si el lactante es mayor o la deformidad grave, estas normas por si solas pueden ya no tener éxito, siendo necesario el uso de ortesis craneal en torno a los 6-7 meses de edad.



Niño con ortesis craneal por plagicefalia postural